

29-Le Système Renal_Croissance et Differentiation

Cette partie-ci, postérieure, va grandir beaucoup plus vite. C'est la partie ici, en avant. Et ça, c'est la partie arrière. Ça va faire ça. Ça va créer, en fait, comme un déchirement ici. L'intestin inférieur, ici, tu vois. Ça, c'est la lontoïde et ça, c'est ce qu'on appelle la zone cloacale, ici. Les égouts, c'est par là où ça sort. Et cette phase de séparation entre mon intestin inférieur et le processus alontoïdien va modifier la partie postérieure dans sa dynamique. Mais c'est engendré par une vitesse de croissance différentielle de la partie postérieure par rapport à la partie antérieure maintenue par la lontoïde et organisée par le foie. Donc, de nouveau, on va voir qu'un des moteurs pour tout ce système D'où l'importance de comprendre cette dynamique et cette relation diaphragmatique et cette globalité de croissance. Parce que c'est un organe, si on regarde, qu'on ouvre un corps, le foie, c'est énorme. Par sa dynamique, il devient organisateur par sa croissance. On décrit ici que les reins semblent monter depuis leur origine sacrée vers la région lombaire. Les surrénales sont en fait induits par la bascule. C'est la bascule du foie qui va créer un champ de croissance pour mes surrénales qui sont énormes, qui descendent avec, et puis à un moment donné, elles ont fait leur travail. On a l'impression qu'elles régressent, mais non, c'est que c'est les autres qui ont grandi. C'est comme ça qu'il faut penser dans le développement embryonnaire. C'est changer des références. Les reins, c'est la croissance des structures postérieures qui viennent les positionner. On a l'impression qu'ils montent, mais en réalité, c'est ceci qui est descendu. C'est tout ceci qui a grandi. Donc le dessin n'est pas juste. Tout ça a grandi, et c'est ça qui va se développer. On va mettre le système urogénital qu'on va relier à ce canal collecteur. On retient que le rein, c'est une concentration de mésodermes. Deuxièmement, il subit une rotation par rapport au mouvement développemental lié aux aortes et à mon tube neural postérieur. Le foie est très important. Puisque c'est lui qui va créer la compression de la partie supérieure à la partie inférieure

pour l'évolution. Je vous rappelle que le foie, dans un embryon, il est relié avec le septum transverseum. Le septum transverseum, il monte haut puisqu'il a une origine embryonnaire au niveau de C3. Mais en fait, il ne bouge plus. C'est tout le système qui grandit autour. Ce qui fait que ça va descendre. Il va donner après l'apparence de se trouver. Donc ça devient des piliers puisqu'il ne bouge pas. Mais c'est tout le système autour qui grandit. Et il termine, si tu veux, sa face au niveau de L2, L3. Mais en fait, c'est tout ceci qui a bougé. Tu vois, c'est l'inverse qui s'est passé. Ce n'est pas ceci qui est descendu. Mais son première origine donne l'impression que c'est à ce niveau-là. Après, c'est toute cette croissance énorme. Donc c'est un énorme point d'appui. Qu'on va avoir besoin. Et là-dessus, tu as le foie qui se développe. Et qui, à un moment donné, devient de plus en plus gros. Et vient établir la compression depuis la partie mesonephrotique. Et puis tu as le méthanéphron qui, lui, ne reçoit pas la pression du foie. Par contre, la partie postérieure grandit. Et mes reins commencent à trouver leur position. Alors, le reste de ce tractus urinaire, donc vessie, se différencie à partir de l'endoblaste de l'intestin postérieur. Puisque là, j'ai mon intestin, le cloaque, la lomptoïde. Et bien, on voit que la vitesse, ici, postérieure de mon tube neural est tellement importante qu'elle va séparer, comme déchirer, l'espace entre la partie future rectum et la partie future vessie donnée par la lomptoïde. Et en fait, la poche ici deviendra simplement, simplement, la vessie. Au départ, la vessie et le rectum, ça faisait un. C'est resté là. Et ça, ça fait ça. Et dans ceci, ça a séparé l'espace cloacal par rapport au rectum et a créé la mise en place. Et les reins, en fait, ils sont restés là. Là, mes deux reins sont là, mes méthanéphrons, et deviennent mon fulcrum par rapport à ma partie postérieure du bassin. Donc, quand je prends le trajet au niveau du rein, je sais que j'ai tout cet axe longitudinal de l'embryon. Quand je mets au niveau de mon sacrum, j'ai un point d'appui. Je mets au niveau de ma loge rénale. Et en fait, le travail, c'est

l'ouverture de motilité, c'est ça. Tu vois, par rapport à mes reins. C'est sa première impulte. Je suis comprimé dans ma partie antérieure. Ça explique bien sa forme. La compression, elle est là. Le niveau rétropéritoneal, ça devient une articulation qui a été créée par deux mouvements. Un qui est organisé par la croissance longitudinale de mon tube neural et deux par le mouvement endodermique. Donc, ça veut dire que l'intégrité de ces deux fonctions sera dépendante de cette articulation intermédiaire. C'est une articulation entre l'ecto et l'endo. Ça veut dire que le système pariétal est dépendant du système mésodermique. C'est pour ça que c'est une voie royale, le mésoderme.